

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE (PHQ-9)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Severidad Depresiva y Cribado de Riesgo Suicida

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario sobre la Salud del Paciente-9 (PHQ-9).
Nombre Original (Inglés)	<i>Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)</i>
Autores Originales	Drs. Kurt Kroenke, Robert L. Spitzer y Janet B. W. Williams (2001), Universidad de Columbia.
Adaptación Española	Díez-Quevedo et al. (2001); validado por Baader et al. (2012) y Saldivia et al. (2019).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado y monitorización terapéutica del Episodio Depresivo Mayor.
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 9 reactivos tipo Likert (0 a 3) + 1 ítem complementario de discapacidad funcional.
Población y Rango	Adultos y adolescentes (a partir de 12 años). Atención primaria, salud mental hospitalaria y comunitaria.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en autoadministración; 3 a 5 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Dominio público científico (desarrollado con beca no comercial de Pfizer Inc.). Uso clínico e investigativo libre.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN

El PHQ-9 fue concebido como el módulo de depresión del *Primary Care Evaluation of Mental Disorders* (PRIME-MD). A diferencia de otras escalas clásicas como la BDI o la HAM-D (que ponderan de forma diferencial síntomas somáticos o ansiosos), el PHQ-9 traslada de forma biunívoca los **9 criterios sintomáticos del Trastorno Depresivo Mayor del DSM-IV/DSM-5**.

Desde la perspectiva neurobiológica, el instrumento evalúa manifestaciones derivadas de la disfunción en los circuitos corticolímbicos (corteza prefrontal dorsolateral, córtex cingulado anterior y complejo amigdalino), reflejando tanto la desregulación afectiva negativa como el déficit mesolímbico dopaminérgico responsable de la anhedonia y pérdida de energía. Su estructura permite un abordaje clinimétrico doble: cuantificación dimensional de gravedad y despistaje categorial sindrómico.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dominio Sintomático	Ítems	Rango Dir.	Criterio DSM-5 Correspondiente
1. Núcleo Afectivo	1 y 2	0 a 6	Anhedonia/desinterés (criterio 1) y estado de ánimo deprimido/desesperanza (criterio 2). Requiere presencia de al menos uno para diagnóstico.
2. Esfera Neurovegetativa	3, 4, 5 y 7	0 a 12	Insomnio/hipersomnia (3), astenia/fatiga (4), alteraciones del apetito o peso (5) y déficit de concentración/indecisión (7).
3. Cognitivo / Psicomotor	6 y 8	0 a 6	Sentimientos de culpa/autorreproche/inutilidad (6) y enlentecimiento o agitación psicomotriz observable (8).
4. Riesgo de Suicidio	9	0 a 3	Pensamientos de muerte o deseos de hacerse daño. Disparador de alerta de riesgo clínico inmediato.
Discapacidad Funcional	Ítem Final	Cualitativo	Impacto global de los síntomas en el trabajo, cuidado del hogar o relaciones interpersonales (Nada, Algo, Mucho, Extremadamente).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en validaciones españolas: alfa de Cronbach de 0.89 en atención primaria (Díez-Quevedo et al., 2001) y 0.86 a 0.91 en pacientes médicos hospitalizados.
Sensibilidad y Especificidad	Sensibilidad del 88% y especificidad del 88% frente a entrevistas psiquiátricas estructuradas (SCID) para el punto de corte óptimo ≥ 10 .
Validez Concurrente	Elevada correlación con BDI-II ($r = 0.84$), HAM-D-17 ($r = 0.78$) y dimensiones de salud mental del SF-36 ($r = -0.73$).
Sensibilidad al Cambio	Efectividad comprobada para monitorizar respuesta farmacológica y psicoterapéutica; una reducción de ≥ 5 puntos o del 50% indica mejoría clínica significativa.
Invarianza Factorial	Estructura unidimensional robusta confirmada en población hispanohablante general, geriátrica y obstétrica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 9 ítems se responde en función de la frecuencia durante las **últimas dos semanas**:

- **0** = Para nada | **1** = Varios días | **2** = Más de la mitad de los días | **3** = Casi todos los días.
- **Puntuación Total PHQ-9**: Suma aritmética directa de los ítems 1 al 9 (Rango total: **0 a 27 puntos**).
- **Algoritmo Categorical DSM**: Se sospecha episodio depresivo mayor si están presentes al menos **5 de los 9 ítems** con puntuación ≥ 2 ("más de la mitad de los días", excepto ítem 9 que cuenta con ≥ 1), siendo obligatorio que uno de ellos sea el ítem 1 o el ítem 2.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE

Severidad	Rango	Estado Clínico	Conducta Terapéutica Recomendada
Mínima	0 a 4	Sintomatología no depresiva	No requiere intervención médica específica. Psicoeducación en hábitos de vida y reevaluación según demanda.
Leve	5 a 9	Síntomas depresivos leves o subumbrales	Vigilancia expectante; reevaluar en 4 semanas. Higiene del sueño, apoyo psicosocial e intervenciones de autoayuda guiada.
Moderada	10 a 14	Depresión clínica moderada (corte ≥ 10)	Indicación de tratamiento formal: psicoterapia basada en evidencia (TCC, activación conductual) y/o farmacoterapia antidepresiva.
Mod. Grave	15 a 19	Depresión mayor moderadamente grave	Tratamiento farmacológico antidepresivo activo combinado con psicoterapia especializada. Seguimiento quincenal.
Grave	20 a 27	Depresión severa / riesgo vital	Intervención psiquiátrica inmediata, farmacoterapia combinada, evaluación exhaustiva de riesgo autolítico y eventual ingreso.

CRITERIO DE CORTE EN ATENCIÓN PRIMARIA: El punto de corte ≥ 10 puntos maximiza el índice de Youden en atención primaria (sensibilidad 88%, especificidad 88%). Puntuaciones de 10 o más exigen descartar comorbilidades somáticas (hipotiroidismo, anemia, déficit B12) y antecedentes hipomaniacos (descarte de Trastorno Bipolar mediante MDQ).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA STEPPED-CARE

PROTOCOLO DE MONITORIZACIÓN CLÍNICA BASADA EN MEDICIÓN (MBC): • **Línea Base:** Aplicación en primera consulta para estratificar gravedad y registrar ideación autolítica basal. • **Semana 4 y 8:** Reevaluación para valorar respuesta precoz: - **Disminución ≥ 5 puntos:** Respuesta clínica adecuada; mantener pauta terapéutica. - **Disminución < 5 puntos:** Falta de respuesta terapéutica; revisar adherencia, ajustar dosis o potenciar psicoterapia. • **Remisión Clínica:** Se define como puntuación final **PHQ-9 < 5 puntos** mantenida en el tiempo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DEPRESIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Paciente: Mujer de 52 años, empleada administrativa, que consulta por astenia persistente de 3 meses de evolución atribuida inicialmente a sobrecarga laboral. Refiere desánimo, cefaleas tensionales e insomnio matutino. Analítica completa normal. **Puntuación PHQ-9 Total: 16 puntos (Nivel Moderadamente Grave).** • **Desglose de reactivos:** Ítem 1 = 3 (anhedonia casi total); Ítem 2 = 2 (desánimo frecuente); Ítem 3 = 3 (despertares precoces a las 4:00 AM); Ítem 4 = 3 (agotamiento severo); Ítem 5 = 1; Ítem 6 = 2 (culpa por bajo rendimiento laboral); Ítem 7 = 2 (dificultades de memoria laboral); Ítem 8 = 0; Ítem 9 = 0 (sin ideación autolítica). Discapacidad: «Muy difícil». **Conducta Asistencial:** Se diagnostica Trastorno Depresivo Mayor episodio único moderadamente grave. Se inicia tratamiento con ISRS (Sertralina 50 mg/día) y derivación a programa breve de Activación Conductual. A las 6 semanas, el PHQ-9 desciende a 6 puntos (reducción de 10 puntos, respuesta clínica favorable) y el sueño se estabiliza.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN OBLIGATORIA DEL ÍTEM 9

ALERTA CRÍTICA: GESTIÓN DEL ÍTEM 9 (SUICIDALIDAD) Cualquier respuesta distinta de cero (**1, 2 o 3**) en el ítem 9 obliga a realizar de inmediato una entrevista clínica específica de riesgo suicida (ej. mediante escala C-SSRS), explorando intencionalidad, planificación, acceso a medios letales y red de soporte familiar.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO En adultos mayores con predominio de deterioro en ítems 4 y 7, descartar deterioro cognitivo incipiente (pseudodemencia depresiva). Descartar siempre viraje maniaco antes de iniciar psicofármacos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2001). The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606–613.
2. Díez-Quevedo, C., Rangil, T., Sánchez-Planell, L., Kroenke, K., & Spitzer, R. L. (2001). Validation and utility of the Patient Health Questionnaire in diagnosing mental disorders in 1003 general hospital Spanish inpatients. *Psychosomatic Medicine*, 63(4), 679–686.
3. Baader, T., Molina, J. L., Venezian, S., Rojas, C., Farías, R., Fierro-Freixenet, C., ... & Mundt, C. (2012). Validación y utilidad de la encuesta PHQ-9 en la determinación de depresión en pacientes de atención primaria en Chile. *Revista Médica de Chile*, 140(12), 1509–1516.
4. Manea, L., Gilbody, S., & McMillan, D. (2012). Optimal cut-off score for diagnosing depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. *CMAJ*, 184(3), E191–E196.